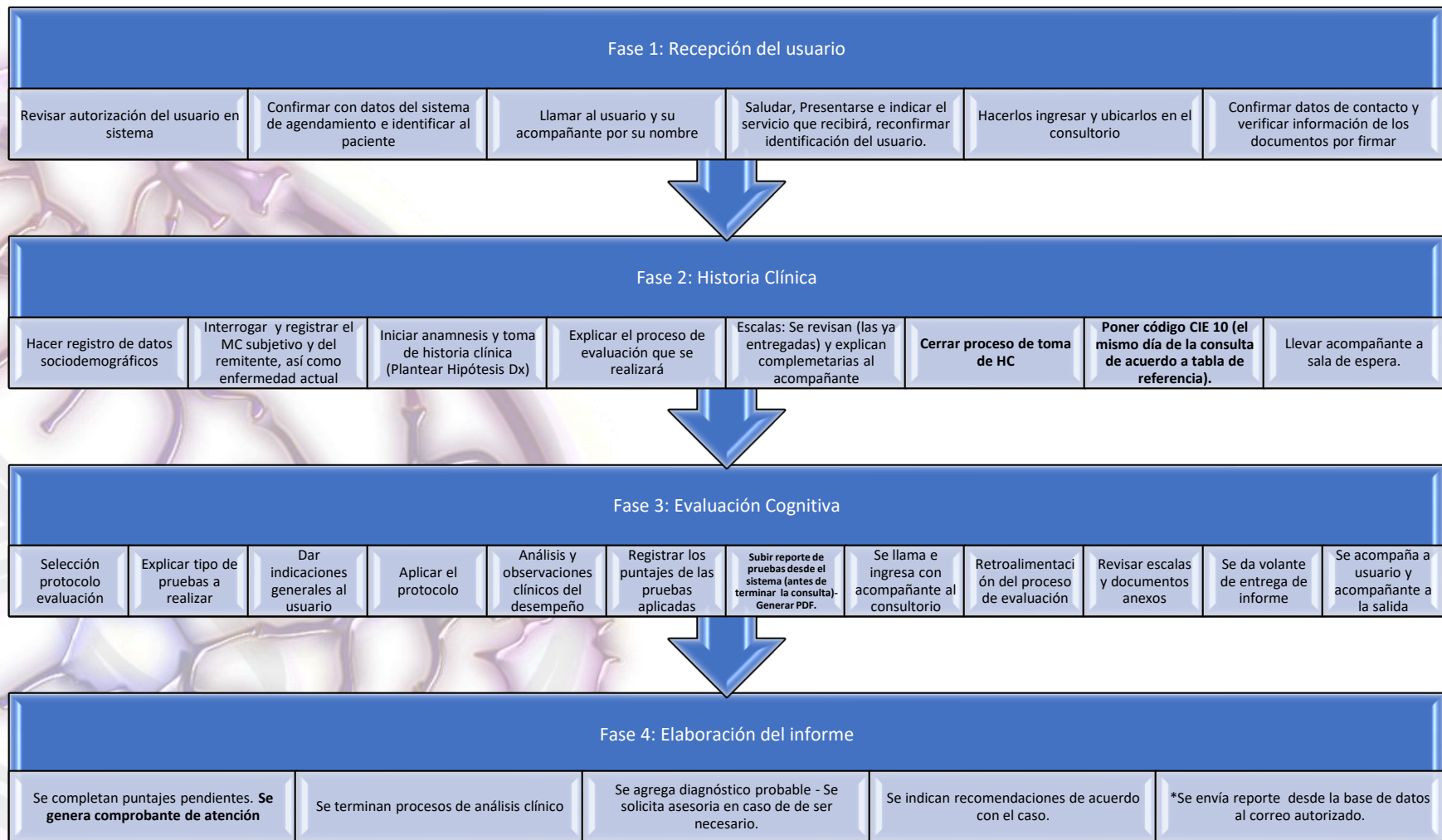


PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PACIENTE- PROCESO ASISTENCIAL SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA IN&S



RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN/CALIDAD

Habilidades Clínicas/ Reglas básicas para la evaluación:

- Prepare al cliente para lo que viene y el proceso que se va a desarrollar.
- Explique la importancia de la evaluación (realización de los tests) para la propia situación del paciente en su vida diaria.
- Prepare al cliente para lo que viene y el proceso que se va a desarrollar.
- Explique la importancia de la evaluación (realización de los tests) para la propia situación del paciente en su vida diaria.
- Provea de un ambiente de evaluación cómodo y agradable.
- Maneje los tiempos de actividad y descansos.
- Divida el tiempo de evaluación cuanto sea necesario.
- Es importante que el evaluador mantenga una actitud amable, neutral y de respeto más que de sumisión o contratransferencia (ver al adulto mayor como sus padres)
- Entregue los resultados de manera oportuna (informe en casos problemáticos o que requieran análisis posteriores al correo electrónico).
- Retroalimente sobre fortalezas y áreas problema, con sugerencia sobre cómo asumir las dificultades.

Condicionantes:

- Respete el tiempo de la consulta y la atención al consultante, por tanto, trate de ejecutar en el tiempo esperado, de no lograrse informe al consultante, así mismo no interrumpa (salir de la consulta, contestar el teléfono en la consulta), a menos que se trate de situaciones de fuerza mayor.

Retroalimentación

- Evalúe el nivel de reconocimiento de las condiciones clínicas del usuario.
- Indique los resultados de la evaluación indicando de forma clara y en lenguaje apropiado para el usuario su rendimiento e impacto en su vida cotidiana
- Trate de explicar los procesos cognitivos que representan fortaleza y dificultad de manera comprensible.
- Indique el posible diagnóstico identificado a partir del perfil clínico y la información recolectada, en caso de aplicar y estar seguro, de acuerdo con el motivo de consulta.
- Dar orientaciones sobre los pasos a seguir (presentar informe al profesional remitente, procesos terapéuticos, etc.)
- Dar recomendaciones funcionales.

Informe

- Envíe el informe al usuario en pdf desde la base de datos
- Genere comprobantes de asistencia u orden de segunda prueba si lo requieren*.

Novedades en la consulta:

- Aplicación del CI en adultos Sí: Se trata de proceso legal para pensión, se sospecha por M.C. y antecedentes de discapacidad no diagnosticada/Control de discapacidad. Si se sospecha con evidencia desde el desarrollo de un posible trastorno del neurodesarrollo (p.e. Dislexia, TDAH, TEA), se recomienda iniciar con CI.
- En niños NO se inicia con CI si ya le fue aplicado en un tiempo menor a 6 meses o se confirma validez de evaluación y se requiere establecer diagnóstico (pues se descarta discapacidad). Se hace evaluación que debe incluir exploración de todas las esferas cognitivas junto con dominios escolares.
- Si el remitente indica necesidad de repetir el CI a pesar de cumplir condiciones anteriores, evaluar el tiempo e iniciar con pruebas complementarias y dar segunda orden para re aplicar el CI en el tiempo prudente.

Manejo de casos que requieren segunda cita:

Casos en que no es viable la evaluación:

- Pacientes enfermos:
 - Alteración del estado de consciencia
 - Síntomas físicos como fiebre, náusea excesiva.
 - Cuadros agudos.
 - Alteración del sueño significativa previa a la evaluación.
 - Estado postictal.

* Idealmente confirmar, que el estado del paciente es un estado agudo o transitorio, que implica que se puede atender de manera regular en otra consulta. Se debe explicar al paciente y familiar ¿por qué no es viable la evaluación y la implicación de la segunda cita (verificar: Copago, si tiene doble orden, si el usuario está de acuerdo, si no puede pagar u otra condición se debe consultar con Dirección Científica).

* Ver formato correspondiente.

- Pacientes con condiciones especiales:
 - Todos los pacientes son evaluables.
 - Se debe escoger el protocolo alterno de acuerdo con la condición.
 - Hacer análisis cualitativo de las funciones cognitivas.

En qué casos se considera viable una segunda cita:

Niños:

- En condición ideal se debe iniciar con CI en los niños (para descartar condición global de aprendizaje).
- Segunda cita sí:
 - La evaluación con la escala de inteligencia no es concluyente para la toma de decisión diagnóstica (p.e. Sospecha trastorno del aprendizaje). Se debe concluir la primera evaluación, indicar los hallazgos y explicar ¿por qué se requiere profundizar en el análisis y los beneficios de este proceso?
 - Sí explícitamente el profesional remitente solicita evaluación con pruebas complementarias y lo amerita el M.C.

- Si el caso amerita extenderse en el proceso de anamnesis y toma de historia clínica, por lo que se va a requerir un nuevo evento para completar el proceso de evaluación.

Adultos:

- La aplicación del protocolo no da suficiente información para dar una conclusión diagnóstica. Se inició con CI y se requiere análisis de funcionamiento cognitivo.
 - Si se requiere protocolo especial por Dx (p.e. EM).
 - Cuando por tiempo no se puede terminar el protocolo en una sesión. Se debe concluir la primera evaluación, indicar los hallazgos y explicar ¿por qué se requiere profundizar en el análisis y los beneficios de este proceso?
- *Siempre se debe dar valor agregado si se amerita segunda consulta.

Cómo gestionar la orden:

- Si se aplicó batería completa de primer evento, pero no conclusivo (p.e. el WISC). Se debe enviar el Informe completo hecho con respuesta al MC o aclaración de NO dx.
- Si no se pudo culminar una batería completa en la primera sesión: colapsar resultados, verificar que no se estén calculando índices de CI, reportar observación y hallazgos en I.Dx. indicando que se requiere profundización y explicar a paciente y acompañante, especialmente por tema de copago (revisar apartado de “Situaciones de procesos inconclusos”).
- Siempre se debe justificar en la conclusión del primer evento el motivo de la segunda cita.
- Dar resumen de HC y orden.
- Sugerencia de redacción: ... “Se solicita segunda evaluación pues se requiere el análisis de profundización de las funciones cognitivas/dominios escolares para hacer definición diagnóstica”.

Indicar en la orden:

- S/S pruebas cognitivas (COD: 930102) para profundización de la evaluación y definición diagnóstica. Generar con el mismo prestador.
- Enviar HC o informe con los elementos evaluados.

Situaciones de procesos “Inconclusos” (que no se pueden evaluar o terminar).

- NO evaluación (por ejemplo, cuando ya traen protocolo aplicado recientemente)
- Retiro voluntario

En caso de no poderse realizar evaluación se debe:

- Diligenciar completa la HC-
- Observación indicando la situación de la consulta y las escalas si se diligenciaron en este apartado.
- Conclusión indicando ¿por qué no se pudo realizar?, la justificación de la situación y/o orientaciones. explicar el análisis de lo evaluado, indicar motivo de NO proceso completo y/o de segunda cita/Alta voluntaria.
- Recomendaciones: Se requiere evaluación complementaria para terminar el proceso de análisis clínico.
- Se genera la HC con los resultados colapsados (quitar resultados)
- Tiempos de envío al paciente:
 - 10 días calendario.

- Formato posible de conclusión ante NO evaluación (ejemplo).
 - Con pruebas recientes p.e.: “Se realiza entrevista y se evidencia que el usuario presenta evaluación neuropsicológica realizada en otra institución en un tiempo menor al estimado para realizar un control. Por este motivo y con el fin de NO sesgar los resultados de la evaluación se hace explicación de los hallazgos presentados (de ser posible), se da orientación y recomendaciones indicando por qué no se puede repetir la evaluación y en cuánto tiempo se debe realizar el control”.

VERIFICACIÓN

- ❖ Verificar fecha de nacimiento y tipo de documento (RM hasta los 6 años, TI de 7 a 17 años, CC: de 18 en adelante, revisar si tiene algún tipo de documento especial).
- ❖ Responder el motivo de consulta: p.e. Si están remitiendo por sospecha de TEA/TDAH, yo debo indicar en la conclusión si tiene o NO la condición, así tenga otro dx.
- ❖ SIEMPRE generar el informe en pdf antes del envío y verificarlo.
- ❖ Cada evento de consulta tiene su informe/evolución, que puede ser la HC o el informe parcial o completo.
- ❖ ¡OJO!: NO Enviar informes con evaluación en blanco.
- ❖ ¡OJO!: NO Enviar informes a correos de otros usuarios o correos equivocados- verificar que la información de contacto quede bien registrada desde el inicio de la consulta. Si el usuario tiene dudas sobre el funcionamiento del correo, debe autorizar el “Formato de envío a terceros” para poder enviar el informe por otro medio (p.e. Whatsapp).
- ❖ Generar el comprobante de pruebas y poner el CIE-10 de cada usuario dentro de la consulta (SOLO LOS DX AUTORIZADOS EN EL DOCUMENTO DE RIPS DE IN&S).
- ❖ Marcar casilla de “segunda cita” en formulario *recetario* cuando se vaya a usar una segunda orden o le den segunda orden al usuario.
- ❖ Verificar redacción, ortografía y digitación en los informes.
- ❖ Al generar el pdf deben verificar que el informe no quede cortado, con espacios en blanco, y la firma en otra hoja, evitando que se pueda perder.
- ❖ Medición del indicador del envío de informes en evaluación de desempeño. Se debe estar completo el envío antes de vacaciones (indicarles a los usuarios de los días previos, que el envío se hará en 10 días hábiles o que indiquen y prioricen si tienen consultas).

Manejo de casos especiales/otros

- Por los protocolos y rutas de atención se debe solicitar:
 - Dirección completa, Nombre completo y edad de madre-padre/acudiente (en el apartado “con quien vive”), nombre del colegio.
- Si hay sospecha de violencia sexual, violencia intrafamiliar y/o de género, EN LOS QUE SEAMOS PRIMER RESPONDIENTE hacer el reporte.
- Pacientes que tengan un evento de salud durante la consulta, se debe indicar activación de ruta de Referencia/Contra-referencia.
- Respuesta a solicitud de ADI y ADOS: Nota: “La prueba solicita es una entrevista y evaluación por observación para el Dx. de TEA, se debe tener certificación en la prueba para aplicarla. NO es una prueba neuropsicológica y por ende no la aplicamos en el protocolo”.

- Respuesta a solicitud de prueba de personalidad: Se debe explicar y dejar Nota: “NO es una prueba neuropsicológica y por ende no la aplicamos en el protocolo”.
- Espacios de inasistencia: Cada espacio de inasistencia es un ingreso que no recibe IN&S, sin embargo, esto NO impacta el pago de las doctoras (en contratos de prestación o por evento se paga por paciente atendido, no por el tiempo contratado). Se implementó nueva estrategia de confirmación para reducir estos espacios, pues estaban generando impacto económico (Del ~10 % al 6 %).
- Si no se está al día con el envío de informes SE DEBE hacer uso de los tiempos destinados a elaboración de informes (aprox. 10 horas semanales) con separación de uso de computador.
- Revisar y conocer los protocolos de base vs. pruebas opcionales, así como los protocolos alternos (p.e. WISC, Los de condiciones sensoriales), ver documento “Protocolos alternos para Casos especiales”.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Versión
Cargo: Dirección Clínica	Cargo: Dirección Clínica Dirección de Operaciones	Cargo: Dirección Clínica Dirección de Operaciones	V.3. 19 de mayo de 2025
Nombre: Ma. Cristina Pinto	Nombre: Susana Lozano Nicolás Contreras	Nombre: Ma. Cristina Pinto Susana Lozano Nicolás Contreras	